

Alkoholipoliitika kohalikul tasandil – pilootprojekti esmased õppetunnid ja tulemused



Triinu Toobal

Vanemspetsialist, Tervise Arengu Instituut

Arutelud kohaliku omavalitsuse rollist alkoholipoliitika kujundamisel ja rakendamisel on kestnud kaua. Ühelt poolt on justkui tegemist piirangute ja reeglitega, mis on teaduskirjandusele tuginedes kõige efektiivsemad siis, kui need on kehtestatud kogu riigis. Teisalt on suhtumine alkoholitarvitamisesse hoiakute ja väärtushinnangute küsimus, mida kohalik omavalitsus saab mõjutada riigist paremini, olles otsekontaktis kogukonnaga.

2014. aastal sai alguse kohalikele omavalitsustele (KOV) mõeldud alkoholipoliitika pilootprojekt, mida rahastati Norra toetustest 2009–2014 rahvatervise programmi raames. Projekti otsene eesmärk on luua tõenduspõhine ja Eesti oludele kohandatud kohaliku alkoholipoliitika raamistik; kaudne eesmärk on tõestada, et kohalikul tasandil alkoholipoliitikasse panustades on võimalik teha muudatusi.

Pilootprojekti osalevad kuus omavalitsust. Kolm nendest – Kuressaare ja Põltsamaa linn ning Põlva vald – viivad ellu spetsiaalse sekkumiskava, ülejäänud kolmes (kontroll-omavalitsusi ei avalikustata) sekkumistegevusi ei toimu. Selline korraldus võimaldab hiljem võrrelda, kas sekkumistegevuste tulemusena on toimunud muutusi alkoholi tarvitamises.

Uuringus osalevates omavalitsustes on 4000–20 000 elanikku, vähemalt 90% rahvastikust on eestlased. Kõigil omavalitsustel on motivatsioon projektis osaleda. Nii sekkumiskava rakendajate hulka kui ka kontrollgruppi kuuluvad kolme tüüpi omavalitsused:

1. Omavalitsus, kus on keskmisest rohkem meelelahutusasutusi. Eesmärk hinnata sekkumise mõju keskkonnas, kus meelelahutusasutused mõjutavad kohaliku alkoholipoliitikat.
2. Lõuna-Eesti omavalitsus. Eesmärk hinnata sekkumise mõju piirkonnas, mis on sotsiaalmajanduslikult kõige keerulisem, ning kus statistika järgi on alkoholi tarvitamisega seotud kahjud kõige suuremad.
3. Väikse elanikearvuga omavalitsus. Ligi kaudu 73% Eesti omavalitsustes jääb Eesti Statistikaameti andmetel elanike arv alla 4000 (213st 155), neist omakorda 91s on elanike arv alla 1500 (59%) (Eesti Statistikaamet 2015).

Projekti kulg

2014. aasta sügisel viidi läbi kõigis kuues omavalitsuses baastaseme uuringud, millega hinnati alkoholi kättesaadavust, alkoholi tarvitamise mustreid, alkoholiga seotud

hoiakuid ning alkoholi tarvitamisega kaasnevate kahjude iseloomu ja määra. Tehti testost, küsitleti nii koolinoori kui ka täiskasvanuid ning viidi läbi fookusgrupiintervjuud kohalike omavalitsuste linna- ja vallavalitsuste või volikogude liikmetega.

Selleks et näidata, kuivõrd tõsise probleemiga silmitsi seisame, toon välja vaid mõned Eesti keskmist iseloomustavad numbrid rahvusvahelise HBSC (*Health Behaviour in School-aged children study*) uuringute tulemustest, mis ei erine pilootprojekti raames selgunud tulemustest:

- Elu jooksul on alkoholi proovinud 11aastastest 31%, 13aastastest (7. ja 8. klassi õpilased) 61% ja 15aastastest õpilastest 84% (Aasvee, Rahno 2015).
- Esimest korda alkoholi proovides oli keskmine vanus poistel 12,3 ja tüdrukutel 12,6 aastat (Aasvee, Rahno 2015), pilootprojekti osalevates omavalitsustes oli alaealiste vanus 11,9–12,9 aastat esmakordsel alkoholi proovimisel.
- Esimest korda purjus olles oli keskmine vanus poistel 13,1 ja tüdrukutel 13,5 aastat (Aasvee, Rahno 2015). Pilootprojekti osalevates omavalitsustes on alaealisena purjus olnud keskmiselt 65% noortest.
- Testostul ei küsitud noortelt vanust tõendavat dokumenti 74% juhul ehk ainult ühel neljast noorest ei õnnestunud poest alkoholi osta (Tael, Aaben 2014), sarnase tulemuseni jõuti ka pilootomavalitsuses testoste tehes.

Pärast esmase uuringu läbiviimist toimus kolme sekkumist elluviiva KOV spetsialistidele baaskoolitus ning 2015. aastaks eraldati neile tegevuste elluviimiseks 3000 eurot. Aasta alguses alustasid kolmes KOVis tööd 3–5liikmelised meeskonnad, kuhu kuulusid omavalitsuse, politsei ja kooli esindajad. Projekti

tegevused suunati alaealistele, kuna fookusgrupiintervjuudes selgus, et omavalitsused on kõige rohkem valmis tegelema noorte alkoholitarvitamisega. Ühtlasi oli elanike vastupanu alaealistega tegelemiseks kõige väiksem, kuna valdav osa elanikkonnast (83%, Eesti Konjunktuuriinstituut 2015) arvab, et alkoholimüügiga seotud õigusrikkumiste (nt müük alaealisele) järelvalvet tuleks parandada.

Sekkumistegevusi viidi ellu neljas valdkonnas: alaealistele alkoholi müügi ja tarvitamise järelvalve korraldamine, kohalike elanike kaasamine ja teavitustöö, süsteemne uimastiennetustöö koolides ning laste ja noorte huviharidus. Omavalitsustes tutvustati uuringutulemusi erinevatele sihtrühmadele (volikogud, koolid, lapsevanemad jne), tulemused avalikustati ka kohalikes meediakanalites; korraldati alkoholiteemaline seminar lapsevanematele; kohtuti erinevate sihtrühmade (koolid, ettevõtjad, kodanikuühendused jne) esindajatega ning teavitati neid võimalustest aidata kaasa alkoholi kättesaadavuse vähendamisele; korraldati uimastiennetusjuhendi infopäev koolidele; tegeleti huviharidusega, kaardistati vaba aja veetmise viisid jms.

Omavalitsuste rahastus tegevuste elluviimiseks lõppes 2015. aasta lõpus. Põhjalik järeluurimise toimumine kõigis kuues omavalitsuses 2017. aastal, pärast seda on võimalik projekti tulemusi analüüsida. Omavalitsused saavad ise otsustada (tulenevalt omavalitsuse juhtide ja meeskonna meelestatusest ja valmisolekust), millisel kujul ja mis mahus nad jätkavad projekti aastatel 2016 ja 2017.

Terve pilootprojekti jooksul (2015–2017) pakub Tervise Arengu Instituut meeskondadele igakülgset tuge: regulaarsed hindamiskoosolekud, motivatsioonikoolitused ja supervisioonid, pilootprojekti vajalikkuse ja toimunud muutuste tutvustamine kohalikes volikogudes jne.

Muutused esimese aasta järel

Kuigi hoiakute ja väärtushinnangute muutumine on pikk protsess, on ka aasta möödudes võimalik märgata mõnda positiivset trendi.

Üks vähestest mõõdetavatest väärtustest, kus muutused on kiirelt näha, on testostu tulemuste muutus ajas: testostu tulemused on kõigis kolmes omavalitsuses paranenud (ühes KOVis on dokumendi küsimise protsent suurenenud üle kahe korra – 2014 sügisel 34,5%, 2015 oktoobris 75%). See tõestab, et regulaarne kontroll koos teenindajate koolitamise ja üldise teavitustööga aitab vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele.

Projektis osalevate meeskondade liikmete sõnul on selgelt näha märke muutustest – muutunud on poemüüjate käitumine ja huvi testostlemise ning alkoholi tarvitamise ennetamise vastu. Teema on leidnud laiemat kõlapinda ka teiste huvirühmade seas – noored, lapsevanemad, ettevõtjad jt. Teema on aktuaalsem kui varem ja tekitab arutelusid, mis ongi teavitustöö eesmärk.

Omavalitsustes toimunud arutelud on loonud pinnase uute ideede rakendamiseks. Näiteks on katsetatud erinevaid piiranguid avalikel üritustel (alkoholivabad üritused, alkoholi müük eraldatud alal jne).

Õppetunnid

Muutuste kõrval on olulised pilootprojekti senised õppetunnid, mis aitavad edaspidi maandada riske tegevuste planeerimisel.

KOVide senist tegevust jälgides on näha, et juhtide toetuseta on äärmiselt keeruline sekkumisi ellu viia. Kui kohalikud otsustajad ei taju alkoholipoliitika tähtsust ega rõhuta tegevuste olulisust, on kogukonnas teemale laiemal kõlapinnal leidmine raske. Veenvate kõneisikute, näiteks volikogu ja valla- või linnavalitsuse juhi sõnavõtted peaksid saatma kogukonnale selge sõnumi, et alkoholipoliitika rakendamine kohalikul tasandil on prioriteet.

Oleme saanud kinnitust, et tegevuste edukus ei sõltu rahast. Aasta alguses eraldatud 3000 eurost oli aasta lõpuks kõigil kolmel omavalitsusel kulutatud keskmiselt pool summast. See tõestab veelkord, et sõltuvusainetevastases võitluses kohalikul tasandil on probleemiks motiveeritud inimeste ja aja, mitte raha leidmine. Alkoholipoliitika rakendamine peab olema meeskonnaliikmetele oluline, kuna tegevusi viiakse ellu teiste töökohustuste kõrvalt – see ei ole ega saa kunagi olema ühe inimese täiskohaga palgatöö (arvestades Eesti omavalitsuste väiksust ning ennetustöö laiahaardelisust – ühe KOVi spetsialisti täiskohaga töö ei võta ära vajadust teiste osapoolte (politsei, kool jne) panustamiseks). Seetõttu on oluline meeskonnaliikmete sisemine motivatsioon ja tahe valdkonnaga tegeleda. Teisalt tuleb sõltuvusainete ennetus- ja teavitustöös sageli ette vastupanu ja eitamist, mistõttu on tähtis roll toetaval ja ühtsel meeskonnal.

Oluline on huvirühmade soov ja valmisolek valdkonnas kaasa rääkida või panustada. Osas gruppides võib huvi tekitamine võtta rohkem aega, samas kui teistel on valmisolek panustamiseks esimesest hetkest. See näitab, et tegevustes on vaja süsteemust ja järjepidevust, et huvirühmadel oleks aega ideedega tutvuda ning oma arvamuseni jõuda. Kõige keerulisemaks koostööpartneriks peetakse tavaliselt ettevõtjaid, kelle majanduslikku heaolu valdkondlikud muudatused justkui otseselt mõjutavad. Meie kogemus väidab vastupidist. Jah, ettevõtjate koostöövalmidus on KOViti erinev (väga tugevalt seotud sellega, millised on kohaliku tasandi kõneisikute suhted ettevõtjatega), kuid pigem ollakse aruteludeks valmis. On oluline, et diskussiooni tekitaks omavalitsus ja kõigil osapooltel oleks võimalik kaasa rääkida.

Veel üks oluline eeldus edu saavutamiseks on kohalike andmete olemasolu. Pilootprojekti

alguses läbiviidud baasuuringud pakuvad väga head statistilist andmestikku, mis kajastab olukorda konkreetses kohalikus omavalitsuses, mitte abstraktsena tunduva Eesti keskmisena. Kohalikud andmed kõnetavad inimesi kõige paremini ja näitavad, et probleem on meie enda noortega, mitte kellegagi kusagil kaugel.

Tulevikuvaade

Selleks et ka teistel omavalitsustel oleks võimalik soovi ja valmisoleku korral tegevustega alustada, on Tervise Arengu Instituut koostöös teiste organisatsioonidega koostanud alkoholipoliitika juhendmaterjali kohalikele omavalitsustele („Võimalused

alkoholipoliitika rakendamiseks kohalikul tasandil”), mille kirjutamisel oli oluliseks sisendiks ka pilootprojekti käigus kogetu.

Alkoholipoliitika juhendmaterjal on ideede pank, mis koondab tõendus põhiseid meetmeid selleks, et omavalitsus saaks ellu viia õigeid tegevusi õigel viisil. Juhendmaterjal on tegevused jaotatud nelja valdkonda: avalike ürituste komplekt, alaealiste tarvitamisele suunatud komplekt, täiskasvanute tarvitamisele suunatud komplekt ning miinimumkomplekt.

Täpsemat informatsiooni pilootprojekti uuringuandmete ja juhendmaterjali kohta on võimalik küsida aadressilt triinu.toobal@tai.ee.



Viidatud allikad

- Aasvee, K., Rahno, J.** (2015). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring. 2013/2014. õppeaasta. Tabelid. intra.tai.ee/images/prints/documents/144776947825_HBSC_2014_kogumik.pdf (22.01.2016).
- Eesti Konjunkturiinstituut** (2015). Alkohol turg, tarbimine ja elanike hinnangud riigi alkoholipoliitikale. intra.tai.ee/images/eventlist/events/27-11-15-alkokonverents_1_Josing.pdf (03.02.2016).
- Eesti Statistikaamet** (2015). Rahvastik soo, vanuserühma ja haldusüksuse või asustusüksuse liigi järgi, 1.jaanuar. Kood: RV0282. (22.01.2016).
- Tael, M., Aaben, L.** (2014). Alkoholsete jookide üle-eestiline testostlemine. Uuringu kokkuvõte. intra.tai.ee/images/prints/documents/142349313797_Uuring_alkohoolsete_jookide_yle-eestiline_testostlemine_2014.pdf (22.01.2016).

*Juhendmaterjal on leitav kahes versioonis terviseinfo.ee kodulehel
Terviseinfo.ee-> alkohol-> alkoholi-poliitika-> alkoholipoliitika Eestis*